

Bon Usage Erleada® 1

Le traitement par Erleada® doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitement du cancer de la prostate.

Indications

mHSPC

Traitement des hommes adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC) en association avec un traitement par suppression androgénique (ADT)

nmCRPC

Traitement des hommes adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (nmCRPC) avec un risque élevé° de développer une maladie métastatique

Il n'est pas possible de positionner ERLEADA® (apalutamide), en association avec un ADT, versus les autres options thérapeutiques disponibles :

- NUBEQA® (darolutamide)*, XTANDI® (enzalutamide) ou ZYTIGA® (acétate d'abiratéron)** au stade mHSPC

- NUBEQA® (darolutamide) ou XTANDI® (enzalutamide) au stade nmCRPC haut risque

les unes par rapport aux autres, faute de données comparatives directes en raison d'un co-développement.

Contre-indications



Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients



Femmes enceintes ou susceptibles de l'être

Excipients

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose de 240 mg# c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi



Convulsions

- Erleada® n'est **pas recommandé** chez les patients ayant des **antécédents** de convulsions ou d'autres facteurs de prédisposition, parmi lesquels, entre autres, une lésion cérébrale sous-jacente, un accident vasculaire cérébral récent (moins d'un an), une tumeur cérébrale primitive ou des métastases cérébrales.
- Le traitement doit être **arrêté définitivement** chez les patients qui présentent des convulsions pendant le traitement par Erleada®. Le risque de convulsion peut être **accru en cas d'utilisation concomitante** de médicaments abaissant le seuil épileptogène.
- Au cours de deux études randomisées (SPARTAN et TITAN), des convulsions se sont produites chez **0,6 %** des patients recevant apalutamide et chez **0,2 %** des patients traités par placebo. Dans ces études, les patients ayant des antécédents de convulsions ou ayant des facteurs prédisposants aux convulsions ont été exclus.
- Il n'y a **pas d'expérience clinique concernant la ré-administration** d'Erleada® chez des patients ayant présenté des convulsions.



Chutes/Fractures

- Des chutes et des fractures sont survenues chez des patients recevant apalutamide.
- Le risque de fracture et de chute **doit être évalué** chez les patients **avant** d'instaurer le traitement par Erleada® et doit **continuer à être surveillé**.
- La prise en charge doit être effectuée **conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur** et l'utilisation d'**agents protecteurs des os** doit être envisagée.

* En association au docétaxel. ** Ou ses génériques, en association avec la prednisone ou la prednisolone au stade mHSPC haut risque pour les patients nouvellement diagnostiqués. ° Risque élevé : temps de doublement du PSA ≤ 10 mois. PSA : Antigène Spécifique de la Prostate.

4 comprimés de 60 mg ou 1 comprimé de 240 mg.



Cardiopathie ischémique & anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire

- Des cardiopathies ischémiques et des anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire, incluant des **événements d'issue fatale**, sont survenues chez des patients traités par apalutamide.
- La majorité des patients avaient des facteurs de risque cardiaque/de maladie cérébrovasculaire ischémique.
- **Une surveillance des signes et symptômes de cardiopathie ischémique et des anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire doit être effectuée chez les patients.**
- La gestion des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète ou les dyslipidémies doit être optimisée conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur.



Utilisation concomitante d'autres médicaments

- L'apalutamide est un **inducteur enzymatique puissant** et peut entraîner une **diminution de l'efficacité** de nombreux médicaments couramment utilisés.
- Une **réévaluation** des traitements concomitants doit être conduite quand le traitement par l'apalutamide est **initié**.
- L'utilisation concomitante d'apalutamide et de médicaments qui sont des substrats cibles de nombreuses enzymes du métabolisme ou de transporteurs doit généralement être évitée **si leur effet thérapeutique pour le patient est important, et si leur posologie ne peut pas être facilement ajustable** sur la base du suivi de l'efficacité ou des concentrations plasmatiques.
- L'administration concomitante d'apalutamide avec la warfarine et les anticoagulants coumariniques doit être évitée. Si Erleada® est administré en même temps qu'un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la warfarine ou l'acénocoumarol), une **surveillance additionnelle** du taux normalisé international (INR) doit être conduite.



Antécédents récents de maladies cardiovasculaires

- Les patients ayant eu une **pathologie cardiovasculaire cliniquement significative** au cours des **6 derniers mois**, notamment angor sévère/instable, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive symptomatique, événement thromboembolique artériel ou veineux (par ex. embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral, y compris accident ischémique transitoire), ou des arythmies ventriculaires cliniquement significatives, ont été exclus des études cliniques. Par conséquent, la sécurité d'utilisation d'apalutamide chez ces patients n'a pas été établie.
- Si Erleada® est prescrit, les facteurs de risque, tels que l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycémie ou d'autres troubles cardiométaboliques, doivent être surveillés chez les patients ayant eu une maladie cardiovasculaire cliniquement significative.
- Si nécessaire, les patients doivent être **traités** pour ces affections **conformément aux recommandations thérapeutiques** en vigueur **après** l'instauration d'Erleada®.



Un traitement par suppression androgénique peut allonger l'intervalle QT

- Chez les patients présentant des **antécédents** ou des **facteurs de risques de l'allongement de l'intervalle QT** et chez les patients recevant de manière concomitante des **médicaments susceptibles d'allonger l'intervalle QT**, les médecins doivent évaluer le rapport bénéfice / risque en prenant en compte le risque potentiel de torsades de pointes avant l'initiation du traitement par Erleada®.



Réactions Indésirables cutanées sévères (SCAR)

- Des cas de réactions indésirables cutanées sévères incluant la réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS), le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/la nécrolyse épidermique toxique (NET), qui **peuvent engager le pronostic vital ou qui peuvent être d'issue fatale**, ont été observés post-commercialisation dans le cadre du traitement par Erleada®.
- Les patients doivent être informés des signes et symptômes évocateurs du syndrome DRESS ou du syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/de la nécrolyse épidermique toxique (NET). **Si ces symptômes sont observés, le traitement par Erleada® doit être arrêté immédiatement et les patients doivent consulter un médecin sans attendre.**
- **Erleada® ne doit pas être re-instauré** chez les patients qui ont présenté un syndrome DRESS ou un syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/une nécrolyse épidermique toxique (NET) lors d'un traitement par Erleada® et une alternative de traitement doit être envisagée.



Pneumopathie interstitielle diffuse

- Des cas de pneumopathie interstitielle diffuse ont été observés chez des patients traités par l'apalutamide y compris des cas **d'issue fatale**. En cas d'apparition aiguë et/ou d'aggravation inexpliquée de symptômes pulmonaires, le traitement par l'apalutamide **doit être interrompu** en attendant des examens complémentaires de ces symptômes.
- Si une pneumopathie interstitielle diffuse est diagnostiquée, l'apalutamide **doit être arrêté et un traitement approprié doit être initié si nécessaire.**

Fertilité, grossesse et allaitement



Contraception chez les hommes et femmes

- La présence d'apalutamide ou de ses métabolites dans le sperme n'est pas connue. Erleada® peut être nocif pour le développement du fœtus. Chez les patients ayant des rapports sexuels avec des femmes en âge de procréer, un préservatif doit être utilisé associé à une autre méthode de contraception hautement efficace pendant le traitement et pendant les 3 mois qui suivent la dernière prise d'Erleada®.



Grossesse

- Erleada® est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou susceptibles de l'être (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). D'après une étude sur la reproduction chez l'animal et son mécanisme d'action, Erleada® peut nuire au fœtus et conduire à l'arrêt de la grossesse lorsqu'il est administré chez la femme enceinte. Il n'existe pas de donnée disponible sur l'utilisation d'Erleada® pendant la grossesse.



Allaitement

- On ne sait pas si l'apalutamide ou ses métabolites sont excrétés dans le lait maternel. On ne peut exclure un risque pour l'enfant allaité. Erleada® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.



Fertilité

- D'après les études réalisées chez l'animal, Erleada® peut diminuer la fertilité chez les mâles aptes à la reproduction (voir rubrique Données de sécurité préclinique du RCP).

Interactions médicamenteuses

L'élimination de l'apalutamide et la formation de son métabolite actif s'effectue autant par l'intermédiaire du CYP2C8 que par celui du CYP3A4 à l'état d'équilibre. **On n'attend aucune modification cliniquement significative de leur exposition globale résultant d'une interaction médicamenteuse avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP2C8 ou du CYP3A4.**

L'apalutamide est un inducteur d'enzymes et de transporteurs et peut accélérer l'élimination de nombreux médicaments couramment utilisés. Des adaptations posologiques peuvent être nécessaires.

Pour plus d'informations, se référer à la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions » du Résumé des Caractéristiques du Produit.

Si Erleada® est administré en même temps qu'un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la warfarine ou l'acénocoumarol), une surveillance additionnelle du taux normalisé international (INR) doit être conduite.

Tolérance générale, Résumé du profil de sécurité¹

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>.

Effets indésirables très fréquents

Fatigue	26 %
Eruption cutanée : Tous grades confondus De grades 3 ou 4	26 % 6 %
Hypertension	22 %
Bouffée de chaleurs	18 %
Arthralgie	17 %
Diarrhée	16 %
Chute	13 %
Poids diminué	13 %
Fractures	11 %
Appétit diminué	11 %

Autres effets indésirables importants et/ou fréquents

Hypothyroïdie	8 %
Neutropénie	
Hypercholestérolémie	
Hypertriglycéridémie	
Dysgueusie	
Cardiopathie ischémique	
Pneumopathie interstitielle diffuse	
Prurit	
Spasmes musculaires	
Syndrome de Stevens-Johnson/ Nécrolyse épidermique toxique	
Réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS)	
Anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire	
Alopécie	

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit Erleada®

Effets indésirables

Classe de systèmes d'organes	Effet indésirable et fréquence
Affections hématologiques et du système lymphatique	• Fréquent : neutropénie • Fréquence indéterminée : agranulocytose
Affections endocriniennes	• Fréquent : hypothyroïdie^a
Troubles du métabolisme et de la nutrition	• Très fréquent : appétit diminué • Fréquent : hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie
Affections du système nerveux	• Fréquent : dysgueusie, anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire^b • Peu fréquent : convulsions^c, syndrome des jambes sans repos
Affections cardiaques	• Fréquent : cardiopathie ischémique^d • Fréquence indéterminée : allongement de l'intervalle QT
Affections vasculaires	• Très fréquent : bouffée de chaleur, hypertension
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	• Fréquence indéterminée : pneumopathie interstitielle diffuse^e
Affections gastrointestinales	• Très fréquent : diarrhée
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	• Très fréquent : éruption cutanée^f • Fréquent : prurit, alopecie • Peu fréquent : éruption lichénoïde • Fréquence indéterminée : réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS)^e, syndrome de Stevens-Johnson/nécrolyse épidermique toxique (SJS/NET)^e
Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif	• Très fréquent : fractures^g, arthralgie • Fréquent : spasme musculaire
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	• Très fréquent : fatigue
Investigations	• Très fréquent : perte de poids
Lésions, intoxications et complications d'intervention	• Très fréquent : chutes

Si une toxicité de grade ≥ 3 ou un effet indésirable intolérable est éprouvé par un patient, plutôt que d'arrêter définitivement le traitement, l'administration doit être suspendue jusqu'à amélioration des symptômes à un grade ≤ 1 ou au grade d'origine, puis doit être reprise à la même dose ou à une dose réduite (180 mg ou 120 mg), si nécessaire.

Fréquences définies comme suit : très fréquent ($\geq 1/10$) ; fréquent ($\geq 1/100$ à $< 1/10$) ; peu fréquent ($\geq 1/1\,000$ à $< 1/100$) ; rare ($\geq 1/10\,000$ à $< 1/1\,000$) ; très rare ($< 1/10\,000$) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité.

a Inclut hypothyroïdie, augmentation de la thyroéstimuline sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-immune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la triiodothyronine.

b Inclut accident ischémique transitoire, accident cérébrovasculaire, trouble cérébrovasculaire, accident ischémique cérébral, artériosclérose carotidienne, sténose carotidienne, hémiparésie, infarctus lacunaire, accident vasculaire cérébral lacunaire, infarctus cérébral thrombotique, encéphalopathie vasculaire, infarctus cérébelleux, infarctus cérébral et ischémie cérébrale.

c Inclut morsure de langue.

d Inclut angine de poitrine, angor instable, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigu, occlusion artérielle coronaire, sténose artérielle coronaire, syndrome coronaire aigu, athérosclérose de l'artère coronaire, épreuve d'effort cardiaque anormale, troponine augmentée, ischémie myocardique.

e Voir rubrique 4.4 du RCP.

f Voir « Éruption cutanée » à la rubrique « Description d'une sélection d'effets indésirables » du RCP.

g Inclut fracture des côtes, fracture vertébrale lombaire, fracture rachidienne par compression, fracture rachidienne, fracture du pied, fracture de la hanche, fracture de l'humérus, fracture vertébrale thoracique, fracture du membre supérieur, fracture du sacrum, fracture de la main, fracture du pubis, fracture acétabulaire, fracture de la cheville, fracture par compression, fracture du cartilage costal, fracture des os du visage, fracture du membre inférieur, fracture ostéoporotique, fracture du poignet, fracture avulsion, fracture du péroné, fracture du coccyx, fracture du bassin, fracture du radius, fracture du sternum, fracture de fatigue, fracture de stress, fracture traumatique, fracture des vertèbres cervicales, fracture du col du fémur, fracture du tibia.

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit Erleada®

Description d'une sélection d'effets indésirables

Type d'EI	Fréquence/Description	
Éruption cutanée	26 % tous grades confondus et 6 % de grade 3 ou 4 (défini comme couvrant une surface corporelle > 30 %)	• Éruption le plus souvent maculaire ou maculopapuleuse • Délai médian avant apparition : 83 jours • Taux de résolution : 78 % • Délai médian de résolution : 78 jours
Fractures	11,7 % (la moitié des patients a subi une chute dans les 7 jours précédant l'événement de fracture)	
Chutes	15,6 %	
Cardiopathie ischémique	4 % dans l'étude SPARTAN et 4 % dans l'étude TITAN Au cours des études SPARTAN et TITAN, 6 patients traités par apalutamide (0,5 %) sont décédés d'une cardiopathie ischémique	
Anomalies ischémiques du système cérébrovasculaire	4 % dans l'étude SPARTAN et 1,5 % dans l'étude TITAN Au cours des études SPARTAN et TITAN, 2 patients (0,2 %) sont décédés d'une anomalie ischémique du système cérébrovasculaire	
Hypothyroïdie	8 % • Patients recevant déjà une hormonothérapie thyroïdienne de substitution : 30 % • Patients ne recevant pas d'hormonothérapie thyroïdienne de substitution : 7 %	

Recommandations pratiques après initiation du traitement¹

Surdosage/oubli de dose/ interactions médicamenteuses

Conduite à tenir



Surdosage

- **Absence d'antidote spécifique** connu en cas de surdosage à l'apalutamide
- En cas de surdosage, la prise d'Erleada® **doit être interrompue et un traitement symptomatique doit être instauré** jusqu'à la diminution ou la disparition de la toxicité clinique
- Aucun événement indésirable en cas de surdosage n'a été observé à ce jour



Oubli de dose

- Si le patient oublie de prendre une dose, il doit la **prendre dès que possible le jour même**, et reprendre le schéma normal le lendemain
- Le patient **ne doit pas prendre de comprimés supplémentaires** pour compenser la dose oubliée



Interactions médicamenteuses

- Si Erleada® est administré en même temps qu'un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la warfarine ou l'acénocoumarol), **une surveillance additionnelle** du taux normalisé international (INR) doit être conduite

DRESS : Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms ; EI : effet indésirable ; NET : Nécrolyse Épidermique Toxique ;
PSA : Antigène Spécifique de la Prostate ; SCAR : Severe Cutaneous Adverse Reactions (Réactions Indésirables cutanées sévères) ;
SSJ : Syndrome de Stevens-Johnson .

1. Résumé des caractéristiques du produit Erleada®.

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit Erleada®